HUALA | LILAC MANDARIN
INDICA-DOMINANTER HYBRID

Genetik
Lilac Diesel x Sunset Mandarin x NL Kush

Geruch
erdig, süß-sauer

Geschmack
erdig, süß-sauer

Wirkung
antiinflammatorisch[1], analgetisch[2], antinociceptiv[2], nicht-sedierend[2]

Produktname

1 HUALA | 2 20 / 22 / 25 / 27 / 30 | 3 1 | 4 UK | 5 LCM

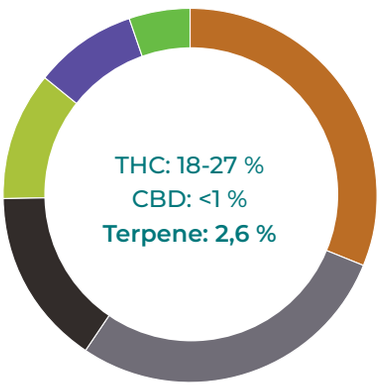
1 Eigenmarke
2 THC SOLL
3 CBD SOLL
4 Herkunft
5 Kultivar

Details zu Lilac Mandarin

Der indica-dominante Hybrid Lilac Mandarin (Lilac Diesel x Sunset Mandarin x NL Kush) vereint ein süß-saures Aromaprofil mit einer stabilen, kompakten Blütenstruktur. Die präzise Genetik garantiert die für die medizinische Versorgung notwendige, reproduzierbare Qualität und Standardisierung.

In der Wirkung als inspirierend eingeordnet, unterstützt der Kultivar primär bei Stress, Angstzuständen, Schmerzen und Appetitlosigkeit. Dank seiner stimmungsstabilisierenden und zugleich alltagstauglichen Eigenschaften fördert er das allgemeine Wohlbefinden, ohne die Funktionalität im Alltag einzuschränken.

- **31 %** L-Fenchon
- **28 %** Terpinolen
- **10 %** β-Caryophyllen
- **9 %** Myrcen
- **5 %** Delta-Limonen
- **15 %** Sonstige



Terpene

Die dominantesten Terpene der Sorte - teilweise ausschlaggebend für den Geschmack, die Wirkung & den Geruch. Mehr Infos zu Terpenen finden Sie auf dem Datenblatt über Terpene und ihre Wirkung.

Prozentualer Anteil vom Gesamtterpengehalt.
Prozentangaben sind Mittelwerte über mehrere Chargen.

Dosierungsbeispiel

Beginn mit einer niedrigen Dosis und langsamen Steigerungen, bis die gewünschte Wirkung erreicht ist.

Standard-Anfangsdosis: 25-50 mg Cannabisblüte pro Tag (ca. 6,25–12,5 mg THC bei 25 % THC)[A]

Unerfahrene Patienten: 10 mg Cannabisblüte pro Tag (ca. 2,5 mg THC bei 25 % THC)[B]

Produktvariationen

Produktname	PZN 5g	PZN 15g	PZN 100g
HUALA 20/1 CA LCM	-	-	20547976
HUALA 22/1 CA LCM	-	-	20547864
HUALA 25/1 CA LCM	-	-	20547901
HUALA 27/1 CA LCM	-	-	20547924
HUALA 30/1 CA LCM	-	-	20547947

Rezeptanforderungen

1. Bei Cannabis muss die **exakte** Produktbezeichnung analog der Herstellervorgabe auf dem Rezept angegeben werden.
2. Weiterhin muss die **exakte** patientenindividuelle Zubereitung und Dosierung mit aufgenommen werden.

Quellennachweise

[1]De Cássia da Silveira e Sá R., Andrade L.N., de Sousa D.P. A Review on Anti-Inflammatory Activity of Monoterpenes. Molecules. 2013;18:1227–1254. doi: 10.3390/molecules18011227.

[2]Him A., Ozbek H., Turel I., Oner A.C. Antinociceptive activity of alpha-pinene and fenchone. Pharmacologyonline. 2008;3:363–369.

[A]Müller-Vahl K., Grotenhermen F. Medizinisches Cannabis: Die wichtigsten Änderungen. Deutsch Ärztebl. International 2017

[B]Horlemann J, Schürmann N. DGS-Praxisleitlinie Cannabis in der Schmerzmedizin. Version: 1.0 für Fachkreise. Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. 2018

Die angegebenen medizinischen Wirkungen beziehen sich auf mögliche Effekte des dominantesten Terpens in der Blüte. Die Angaben sind lediglich ein Anhaltspunkt für die passende Produktauswahl durch das medizinischen Fachpersonal und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.